ROTEIRO DE ESTUDO PARA A APRESENTAÇÃO ORAL

Alopecia Androgenética Feminina e Saúde Gastrointestinal — estudo de caso
Acadêmica: Paola Bortoli Pinheiro Lopes — Tecnologia em Estética e Cosmetologia — UNIPLAC

Como usar este material: este roteiro NÃO é para decorar. Ele é um guia. Leia cada bloco, entenda a ideia central e depois treine falando com as suas próprias palavras. Se você conseguir explicar cada slide sem olhar o roteiro, você está pronta.

1. Resumo executivo — o "elevator pitch" do trabalho

Este é um artigo científico no formato de **estudo de caso descritivo e qualitativo**, com uma única paciente. Ela nasceu em 1964 — tinha 60 anos no início do acompanhamento e 61 na reavaliação mais recente — e procurou atendimento por queda e rarefação progressiva no topo da cabeça (vértice), com cerca de três anos de evolução. O diagnóstico estético-funcional foi de **alopecia androgenética feminina (AAF)**, sustentado por anamnese, tricoscopia e registro fotográfico padronizado. Ela tem histórico familiar de calvície (pai), gastrite crônica em tratamento, infecção por **Helicobacter pylori já erradicada e comprovada por exames**, alterações hormonais, histórico de química capilar, estresse elevado, sono fragmentado e uso contínuo de medicação cardiovascular.

O protocolo foi aplicado **em duas fases e sempre em paralelo ao acompanhamento médico**. A Fase 1 foi de desinflamação: aromaterapia, argiloterapia e fotobiomodulação com luz azul, duas vezes por semana, para controlar inflamação e oleosidade — porque só um couro cabeludo equilibrado responde bem ao estímulo. A Fase 2 foi de estímulo: intradermoterapia capilar com a Mescla PHD pela técnica de pápula, quinzenal, e fotobiomodulação com luz vermelha (650–660 nm, cerca de 20 minutos), duas a três vezes por semana. Em casa, uso diário contínuo do tônico Capilia Longa mais orientações de higienização, alimentação, sono e manejo do estresse. Reavaliação bimestral por tricoscopia e foto.

O que se observou até agora: **a evolução não foi linear**. A Fase 1 controlou bem a inflamação e a oleosidade. Na entrada da Fase 2 a resposta ficou abaixo do esperado e a paciente percebeu aumento transitório da queda; a reanamnese mostrou higienização insuficiente, com acúmulo de sebo sobre os óstios foliculares, e uso irregular do tônico em casa. Houve **correção de conduta** — reforço de orientação, revisão dos produtos, retomada sistemática do tônico e checagem da adesão a cada sessão — e a série de sessões foi estendida. Depois disso, observou-se melhora do couro cabeludo, aumento da microcirculação e surgimento de novos fios nos espaçamentos das áreas antes rarefeitas. A conclusão honesta: **a adesão domiciliar foi o fator mais determinante da resposta**, e a condição gastrointestinal é tratada como **fator associado, nunca como causa** da alopecia androgenética.

Versão de 30 segundos (para decorar de verdade): "É um estudo de caso de alopecia androgenética feminina numa paciente de 61 anos com histórico de gastrite e H. pylori já erradicada. Apliquei um protocolo estético em duas fases — primeiro desinflamar, depois estimular — com fotobiomodulação, intradermoterapia e cuidado domiciliar, em paralelo ao médico. Houve melhora do couro cabeludo e fios

novos, mas só depois de corrigir a adesão da paciente em casa, que foi o fator mais decisivo. A questão gastrointestinal entra como fator associado, por má absorção de nutrientes, e não como causa."

2. Roteiro slide a slide (apresentação do seminário — 21 slides)

Para cada slide: a ideia central que você precisa comunicar. **Fale com as suas palavras. Não leia o slide.** O slide é apoio visual para a plateia; a explicação é você.

Slide 1 — Capa

Apresente-se com calma: nome, curso, e diga o título do trabalho em linguagem simples. Em uma frase, anuncie o que a plateia vai ver: um estudo de caso de alopecia androgenética feminina numa paciente com histórico de gastrite e H. pylori já erradicada, acompanhada com um protocolo estético. Não corra aqui — é o momento em que a banca calibra o seu ritmo.

Lembrete: Cite as orientadoras pelo nome já na abertura.

Slide 2 — Resumo do trabalho

Dê o mapa antes do território. Diga que é um estudo de caso descritivo e qualitativo, com uma paciente só; apresente a paciente em uma frase; diga os três recursos (fotobiomodulação, intradermoterapia e cuidado domiciliar) e antecipe o desfecho: houve melhora e fios novos, precedidos de uma fase inicial em que o resultado ficou aquém por baixa adesão. Antecipar a parte que não deu certo mostra segurança, não fragilidade.

Slide 3 — Como está organizado o artigo

Slide curto, fala curta. Diga só que a apresentação segue a estrutura do artigo: introdução, desenvolvimento, método, discussão e considerações finais. Não leia os cinco itens um a um — resuma e siga.

Lembrete: Máximo 20 segundos.

Slide 4 — Introdução — a AAF

Explique o que é a alopecia androgenética: a queda capilar mais comum e progressiva, causada pela ação da DHT em folículos geneticamente predispostos. Destaque o padrão feminino: rarefação difusa do topo, preservando a linha frontal. Use o dado de prevalência (de ~1,3% entre 18 e 29 anos para ~11,8% após os 70) para mostrar por que o caso de uma paciente nessa faixa etária é relevante. Termine com o objetivo do artigo.

Slide 5 — Fisiopatologia — DHT e genética

Conte o mecanismo como uma história: a enzima 5-alfa-redutase transforma testosterona em DHT; a DHT encurta a fase anágena e miniaturiza o folículo, trocando fio terminal por velo; a relação anágeno/telógeno, que normalmente é de cerca de 12 para 1, cai. Feche conectando com o caso: herdabilidade estimada em 0,81 e o pai da paciente é calvo.

Lembrete: Esse é o slide técnico — fale devagar e explique 'miniaturização' com palavras simples.

Slide 6 — Quadro clínico e escala de Ludwig

Mostre que existe classificação objetiva. Padrão feminino é afinamento da coroa com preservação da frente; a escala de Ludwig divide a gravidade em três estágios e serve para planejar o protocolo e comparar a evolução ao longo do tempo.

Slide 7 — Fatores sistêmicos — absorção de micronutrientes

Aqui entra a parte gastrointestinal, que é o diferencial do trabalho. Explique a cadeia: H. pylori e gastrite crônica reduzem a acidez gástrica; sem acidez, cai a absorção de ferro não heme e de vitamina B12; o próprio tratamento (inibidor de bomba de prótons, usado por tempo prolongado) faz o mesmo. E ferritina baixa está associada à alopecia feminina — média de 37,3 ng/mL nas pacientes contra 59,5 nos controles. O folículo é uma das estruturas de maior taxa mitótica do corpo, então depende desses nutrientes para manter a fase de crescimento.

Lembrete: Este é o slide que constrói a ponte. Não atropele.

Slide 8 — Delimitação científica: fator associado, nunca causa

Este é o slide mais importante do ponto de vista metodológico e o que a banca mais pode cutucar. Diga com todas as letras: a evidência DIRETA que liga H. pylori à queda capilar é de alopecia AREATA, que é autoimune, e não da androgenética. Eu não afirmo causalidade. O que a literatura sustenta é uma ponte indireta e plausível, pela má absorção de micronutrientes. Por isso trato a condição gastrointestinal como fator coadjuvante e potencialmente acelerador. E isso tem uma consequência prática: como pode haver má absorção, faz sentido levar o ativo direto pela via intradérmica.

Lembrete: Se você só tiver tempo para defender um slide, defenda este.

Slide 9 — Ambiente folicular e progressão

Explique que a AAF não é só hormonal: inflamação de baixo grau e microcirculação perifolicular comprometida também participam do ambiente que acelera a miniaturização. Deixe claro que se trata de elo de plausibilidade, não de relação determinística.

Lembrete: Atenção: na versão da Mostra Científica o mecanismo de 'estresse oxidativo' foi retirado por não haver exame laboratorial que o comprove nesta paciente. Veja a pergunta 3 da seção 3.

Slide 10 — Fotobiomodulação

Justifique a escolha: é não invasiva, segura e tem eficácia demonstrada em ensaios randomizados. Mecanismo: aumenta a produção de ATP nas células foliculares, melhora a microcirculação e prolonga a fase anágena. Resultado de literatura: ganho de cerca de 41,9 fios/cm² sem efeitos adversos. Parâmetros: luz vermelha de 650 a 660 nm, 1 a 10 J/cm², 15 a 20 minutos. Explique a resposta bifásica — dose baixa estimula, dose alta inibe — e diga que por isso trabalhou com fluência baixa. A luz azul entrou antes, na Fase 1, para inflamação e oleosidade.

Slide 11 — Intradermoterapia e cuidado domiciliar

Conecte com o slide 8: a microinjeção leva o ativo direto ao folículo e contorna as barreiras de absorção gastrointestinal. Descreva a técnica de pápula: agulha 30G, 2 a 4 mm, cerca de 0,05 a 0,1 mL por ponto, pápulas a cada 2 cm. Cite a composição da Mescla PHD (minoxidil, nanofatores, latanoprosta, Pill Food e lidocaína). No home care, o tônico Capilia Longa, à base de cúrcuma, que auxilia na inibição da conversão de testosterona em DHT, além de higienização, alimentação, sono e manejo do estresse.

Slide 12 — Método — desenho do estudo e a paciente

Diga que é pesquisa qualitativa, estudo de caso descritivo, com uma única paciente, e que o referencial teórico veio de PubMed/PMC, SciELO, periódicos de dermatologia e tricologia e livros-texto. Depois apresente a paciente: nascida em 1964, queixa de rarefação no topo há cerca de três anos, calvície paterna, gastrite crônica em tratamento, H. pylori já erradicada e confirmada por exames (Anexos A a G), alterações hormonais, química capilar, estresse e sono fragmentado, e medicação contínua cuja bula descreve edema e retenção hídrica entre os efeitos possíveis.

Slide 13 — Método — instrumentos e diagnóstico

Explique como avaliou: anamnese capilar, tricoscopia com fotovideodermatoscópio e foto padronizada — mesma luz, mesmo enquadramento, mesma distância, o que é o que torna a comparação válida. Na avaliação inicial havia sinais inflamatórios, hiperemia e oleosidade aumentada. Nos achados tricoscópicos: rarefação no vértice, miniaturização, maior espaçamento interfolicular e diversidade de calibre (anisotricose), presente em cerca de 90% dos casos femininos e considerada o marcador mais confiável; a tricoscopia supera o tricograma (72% contra 62%).

Slide 14 — Quadro 1 — síntese do protocolo

Não leia a tabela linha por linha. Conte a lógica: primeiro desinflamar, depois estimular, porque só um couro cabeludo equilibrado responde ao estímulo. Diga a Fase 1 (aromaterapia, argiloterapia, luz azul, 2x/semana), a Fase 2 (intradermoterapia quinzenal e luz vermelha 2 a 3x/semana), o home care diário e a reavaliação bimestral. Termine dizendo que a série inicialmente prevista foi estendida por causa da resposta mais lenta que o esperado.

Lembrete: Deixe a plateia ler a tabela enquanto você narra a lógica.

Slide 15 — Aspectos éticos

Fale com firmeza: Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPLAC sob o número 6.603.39, e TCLE assinado pela paciente modelo autorizando os procedimentos, o registro fotográfico e a divulgação acadêmica das imagens e dos exames, com a identificação preservada.

Lembrete: Decore o número do CEP: 6.603.39. É pergunta clássica de banca.

Slide 16 — Discussão — o que foi bem

Comece assumindo que a evolução não foi linear e que relatar isso com honestidade faz parte do resultado científico. Depois: a Fase 1 controlou inflamação e oleosidade; o couro cabeludo ficou equilibrado, que era a condição necessária para estimular; e, após a correção de conduta, houve aumento da microcirculação e surgimento de novos fios nos espaçamentos das áreas antes rarefeitas, acompanhado por tricoscopia e foto padronizada.

Slide 17 — Discussão — o que não foi bem e como foi corrigido

Conte a história de forma direta: na transição para a Fase 2 a tricoscopia não mostrou o ganho de densidade previsto e a paciente percebeu aumento transitório da queda. A reanamnese revelou o motivo: higienização insuficiente, com intervalos longos entre lavagens e acúmulo de sebo sobre os óstios foliculares, e uso irregular do tônico. A correção de conduta foi reforçar a orientação de frequência e técnica de higienização, revisar os produtos de casa, retomar o tônico de forma sistemática e passar a acompanhar a adesão a cada

sessão. Depois do ajuste a resposta clínica mudou de forma perceptível, e a série foi estendida. Conclusão: a adesão domiciliar foi o determinante mais evidente da oscilação.

Lembrete: Este slide é uma força do trabalho, não uma falha. Apresente com postura de quem conduziu bem o caso.

Slide 18 — Discussão — o que o caso NÃO permite afirmar

Mostre maturidade científica. Não dá para atribuir o resultado a um único recurso, porque o protocolo foi combinado. Caso único não permite inferência causal nem generalização. Existem fatores de confusão: a natureza multifatorial da AAF (genética, hormônios, idade, química capilar), a adesão, o sedentarismo, o estresse, o sono fragmentado e a medicação contínua. E sobre a H. pylori, reitere: coexistência e fator associado plausível, não relação de causa e efeito — a evidência direta é de alopecia areata, de mecanismo autoimune distinto.

Slide 19 — Considerações finais

Feche em três ideias. Uma: o protocolo em duas fases foi bem tolerado e acompanhou-se de melhora do couro cabeludo e de fios novos nas áreas rarefeitas. Duas: a adesão domiciliar foi o fator mais determinante, o que significa que educar e acompanhar a paciente são parte do protocolo, e não recomendações acessórias. Três: a saúde gastrointestinal é fator sistêmico associado, com plausibilidade mecanística, nunca causa isolada. Termine com as limitações (caso único, sem controle, recursos combinados, avaliação qualitativa) e a sugestão para estudos futuros: amostras maiores, dosagem seriada de ferritina, B12 e zinco e medida quantitativa de densidade.

Lembrete: Este é o slide que a banca lembra. Ensaie-o mais do que os outros.

Slide 20 — Referências principais

Não leia as referências. Diga apenas que são as principais e que a lista completa, com links e datas de acesso, está no artigo entregue em Word e PDF.

Lembrete: 10 segundos.

Slide 21 — Anexos, créditos e agradecimentos

Explique que os Anexos A a G trazem os exames anatomopatológicos e endoscópicos de 2025 e o exame de controle de 2026, que confirma a erradicação da infecção — todos apresentados mediante autorização expressa no TCLE, e que comprovam o acompanhamento médico sem serem objeto de análise laboratorial neste estudo. Cite as orientadoras com a titulação completa e agradeça à paciente modelo, às professoras e ao corpo docente.

Lembrete: Se o Anexo H (ficha de anamnese) ainda não estiver digitalizado, veja a pergunta 4 da seção 3.

Se você for cortada por falta de tempo: vá direto para os slides 8, 14, 17 e 19. Eles contêm, juntos, a delimitação científica, o protocolo, a história real do caso e a conclusão.

2.1 Adaptação para a Mostra Científica (10 slides)

A apresentação da Mostra é uma versão enxuta da mesma história. O conteúdo é o mesmo, o ritmo é mais rápido. Use os blocos acima na seguinte compactação:

- Abertura e resumo: slides 1 e 2 do roteiro.
- Introdução e fisiopatologia: junte 4 e 5 em uma fala só.
- Conexão gastrointestinal: slides 7 e 8 — mantenha os dois, é o diferencial do trabalho.
- Metodologia, protocolo e linha do tempo: junte 12, 13 e 14.
- Ética: slide 15, sempre.
- Fundamentação teórica e resultados parciais: junte 16 e 17, e deixe claro que o estudo está EM ANDAMENTO e que os resultados são parciais.
- Considerações e limitações: junte 18 e 19.

Diferença de vocabulário entre as duas versões: na Mostra, o estudo é apresentado como **em andamento, com resultados parciais**, e a paciente é descrita como **nascida em 1964 (60 anos ao início do acompanhamento, 61 na reavaliação mais recente)**. Use essa mesma formulação se perguntarem a idade, em qualquer das duas apresentações — é a mais precisa.

Linha do tempo (peça isso de cor): no terceiro semestre do curso iniciou-se a terapia capilar como preparo da pele, com foco em home care; neste ano constatou-se piora do quadro, o que motivou nova avaliação; a partir da reavaliação houve melhora dos hábitos domésticos — higienização e lavagem mais frequentes e adequadas — em conjunto com o apoio médico, que contribuiu para a melhora do quadro gastrointestinal.

3. Perguntas prováveis da banca e respostas-modelo

As respostas abaixo são modelos de raciocínio, não textos para decorar. O padrão de uma boa resposta é: **reconhecer a pergunta → responder com o dado → dizer o limite**.

Pergunta 1 — "Por que você diz que o H. pylori está relacionado, se a evidência direta é de alopecia AREATA e não de androgenética?"

- Reconheça de imediato, sem defensiva: "Essa é exatamente a delimitação que o trabalho faz de forma explícita. A evidência direta que liga H. pylori à queda capilar está concentrada na alopecia areata, que tem mecanismo autoimune, diferente da androgenética. Eu não afirmo em nenhum momento que a infecção cause a alopecia androgenética."
- Explique a ponte: "O que eu sustento é uma ponte mecanística indireta e plausível. A H. pylori e a gastrite crônica reduzem a acidez gástrica, e essa redução prejudica a absorção do ferro não heme e da vitamina B12. O uso prolongado de inibidor de bomba de prótons, que é o tratamento da gastrite, tem o mesmo efeito. E ferritina baixa está associada à alopecia feminina — Kantor et al. encontraram média de 37,3 ng/mL nas pacientes contra 59,5 nos controles. O folículo é uma das estruturas de maior taxa mitótica do corpo e depende desses nutrientes para sustentar a fase anágena."
- Feche com o limite e com a consequência prática: "Por isso trato a condição gastrointestinal como fator coadjuvante e potencialmente acelerador, jamais como causa determinante. E ela teve uma consequência terapêutica concreta: como pode haver má absorção, a via intradérmica, que entrega o ativo direto no plano dérmico, é coerente com o perfil desta paciente."
- NUNCA diga: "a H. pylori causou a alopecia dela". Diga sempre fator associado, coexistência, plausibilidade mecanística.

Pergunta 2 — "Por que os resultados pioraram antes de melhorar?"

- Assuma a história real, ela valoriza o trabalho: "Na transição para a Fase 2, a tricoscopia não mostrou o ganho de densidade previsto e a paciente percebeu aumento transitório da queda."
- Explique a investigação: "Fiz uma reanamnese e encontrei a causa: a higienização estava insuficiente, com intervalos longos entre as lavagens e acúmulo de sebo sobre os óstios foliculares, e o uso do tônico domiciliar estava irregular. Ou seja, o estímulo em cabine estava sendo aplicado sobre um couro cabeludo que não estava sendo mantido em casa."
- Mostre a conduta: "Corrigi a conduta: reforcei a orientação de frequência e técnica de higienização, revisei os produtos usados em casa, retomei o tônico de forma sistemática e passei a acompanhar a adesão a cada sessão. Também estendi a série de sessões, adequando o cronograma ao ritmo real da paciente. Depois do ajuste, a resposta clínica mudou de forma perceptível."
- Conclua com o aprendizado: "Isso mostrou que a adesão domiciliar foi o determinante mais evidente da oscilação da resposta — e é por isso que, na minha conclusão, educação e acompanhamento próximo são componentes do protocolo, e não recomendações acessórias."

Pergunta 3 — "Por que vocês removeram a menção ao estresse oxidativo?"

- Responda com rigor, não com desculpa: "Porque não temos exame laboratorial que comprove estresse oxidativo nesta paciente. O que temos é relato subjetivo colhido em anamnese sobre privação de sono e abalo psicológico."

- Explique o critério: "Estresse oxidativo é um mecanismo bioquímico. Afirmá-lo exigiria dosagem de marcadores — capacidade antioxidante total, malondialdeído, superóxido dismutase. Como eu não dosei esses marcadores neste caso, eu preferi não afirmar um mecanismo bioquímico sem evidência direta no meu próprio paciente."
- Vire a favor do trabalho: "Essa retirada é rigor científico, não fragilidade do trabalho. A literatura descreve estresse oxidativo na alopecia androgenética de forma geral, mas eu só posso afirmar sobre a minha paciente aquilo que eu de fato mensurei. Inclusive isso está entre as sugestões para estudos futuros: dosagem seriada de ferritina, B12 e zinco e medida quantitativa de densidade."
- Se perguntarem por que ainda aparece na versão do seminário: diga que a versão da Mostra Científica é posterior e aplicou um critério mais estrito de evidência, e que a delimitação — fator associado, nunca causa — é a mesma nas duas versões.

Pergunta 4 — "Qual a diferença entre Apêndice e Anexo no seu trabalho, e por que a ficha de anamnese ainda não está anexada?"

- Defina corretamente: "Anexo é o documento produzido por terceiros, que eu não elaborei — no meu caso, os exames anatomopatológicos e endoscópicos de 2025 e o exame de controle de 2026, que estão nos Anexos A a G. Apêndice é o documento elaborado pela própria autora."
- Seja honesta sobre a pendência: "A ficha de anamnese capilar está referida no trabalho como Anexo H e ainda está pendente de digitalização e inclusão. Ela é um instrumento que eu mesma preenchi durante a avaliação, portanto, pelo critério acima, o lugar mais correto para ela seria como Apêndice."
- Mostre encaminhamento: "Vou digitalizá-la e incluí-la na versão final, ajustando também a chamada no texto da seção 3.3 Instrumentos de avaliação."
- Dica: se possível, resolva essa pendência ANTES da apresentação. É a única fragilidade formal conhecida do trabalho e é fácil de eliminar.

Pergunta 5 — "Como foi a aprovação ética deste trabalho?"

- "O trabalho seguiu os princípios éticos da pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPLAC sob o número 6.603.39."
- "A paciente modelo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando expressamente a realização dos procedimentos, o registro fotográfico e a divulgação acadêmica das imagens e dos exames apresentados nos anexos, preservada a sua identificação."
- Se perguntarem sobre os exames: "Eles comprovam o acompanhamento médico e a erradicação da infecção; não são objeto de análise laboratorial neste estudo, e estão no trabalho apenas mediante a autorização expressa no TCLE."

Pergunta 6 — "Quem são as suas orientadoras e qual a titulação delas?"

- "Profa. Marcia de Liz — Tecnóloga em Cosmetologia e Estética pela UNIPLAC, Especialista em Estética e Imagem Corporal, MBA em Tricologia, Coordenadora do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC e tricologista."
- "Profa. Mariana Macedo Justi — Biomédica e Cosmetóloga Esteta pela UNIPLAC, Especialista em Biomedicina Estética e em Ozonioterapia na Estética."
- Decore isso. É a pergunta mais fácil de errar por nervosismo e a mais constrangedora de não saber.

Pergunta 7 — "Por que você não pode atribuir o resultado à fotobiomodulação ou à intradermoterapia isoladamente?"

- "Porque o protocolo foi combinado. Apliquei fotobiomodulação, intradermoterapia e cuidado domiciliar simultaneamente, então não é possível isolar a contribuição de cada recurso."
- "Além disso, é um estudo de caso único, sem grupo controle, o que por delineamento não permite inferência causal nem generalização. Existem ainda fatores de confusão: a natureza multifatorial da AAF, a adesão da paciente, o estresse, o sono fragmentado e a medicação contínua, cuja bula descreve edema e retenção hídrica entre os efeitos possíveis."
- "O que o caso oferece é a descrição detalhada e honesta de uma conduta clínica e da sua evolução real — inclusive da fase em que não funcionou — o que tem valor didático e gera hipóteses para estudos maiores."

Pergunta 8 — "Por que escolheu a via intradérmica e não só o tratamento tópico?"

- "Porque a microinjeção leva o ativo direto ao folículo, no plano dérmico, contornando as barreiras de absorção. No caso desta paciente isso é especialmente coerente, porque há histórico de gastrite crônica e de H. pylori, condições associadas a prejuízo de absorção de micronutrientes."
- "A técnica usada foi a de pápula: agulha 30G, profundidade de 2 a 4 mm, cerca de 0,05 a 0,1 mL por ponto, com pápulas a cada 2 cm. A composição foi a Mescla PHD: minoxidil 8 mg, nanofatores 1%, latanoprosta 50 mcg, Pill Food e lidocaína 20 mg."
- "E o tópico não foi abandonado: o home care com tônico Capilia Longa foi mantido diariamente — e, como mostrei na discussão, foi justamente a irregularidade nesse uso que fez a resposta estagnar."

Pergunta 9 — "Por que fazer duas fases, e não começar direto pelo estímulo?"

- "Porque só um couro cabeludo equilibrado responde bem ao estímulo. Na avaliação inicial havia sinais inflamatórios, hiperemia e oleosidade aumentada. Estimular um folículo em ambiente inflamado é desperdiçar o recurso."
- "Por isso a Fase 1 foi de desinflamação, com aromaterapia, argiloterapia e fotobiomodulação com luz azul, duas vezes por semana. Só depois de confirmar a redução da hiperemia e da oleosidade é que entrei na Fase 2, com intradermoterapia quinzenal e luz vermelha."
- "Essa lógica também se apoia na resposta bifásica da fotobiomodulação: dose baixa estimula e dose alta inibe, então usei fluências baixas na fase de estímulo."

Pergunta 10 — "O estudo está concluído? Quais os próximos passos?"

- "O acompanhamento está em andamento e o que apresento são resultados parciais, acompanhados por tricoscopia e registro fotográfico padronizado, com reavaliação bimestral."
- "Os próximos passos que eu proponho são: amostras maiores, dosagem seriada de ferritina, vitamina B12 e zinco, e medida quantitativa de densidade capilar, para transformar a avaliação predominantemente qualitativa em dado objetivo."

4. Postura, tempo de fala e ensaio

O que a professora orientou

- **Fale com as suas palavras — não leia o slide.** O slide é apoio visual para quem assiste. Se você ler, a banca percebe na hora e o domínio do conteúdo fica em dúvida. Olhe para a plateia, não para a tela.
- **Não atropele as informações.** Melhor dizer menos coisas com clareza do que despejar tudo. Respire entre os blocos. Termine a frase antes de passar o slide.
- **Ensaie antes, em voz alta e cronometrando.** Ensaiar em silêncio não funciona — o tempo real de fala é sempre maior do que o imaginado. Ensaie pelo menos três vezes de ponta a ponta.
- **Cuide o tempo.** Saiba quanto tempo você tem e divida por blocos. Se perceber que está atrasada no meio, corte os slides de apoio (3, 6 e 20), nunca os slides 8, 17 e 19.
- **Tenha certeza de que consegue explicar o trabalho inteiro em poucas frases.** Se o tempo for cortado, use a versão de 30 segundos da seção 1 deste roteiro. Essa é a única parte que vale decorar literalmente.

Checklist de ensaio

- Ensaiei em voz alta, cronometrando, pelo menos 3 vezes.
- Consigo explicar o slide 8 (fator associado, nunca causa) sem olhar nada.
- Sei de cor: número do CEP 6.603.39, Resolução 466/12, TCLE.
- Sei de cor a titulação das duas orientadoras.
- Sei a idade da paciente na formulação correta: nascida em 1964, 60 anos ao início, 61 na reavaliação mais recente.
- Sei contar a história da piora e da correção de conduta sem soar como desculpa.
- Testei o arquivo no computador da apresentação (fontes, imagens da tricoscopia, ordem dos slides).
- Resolvi (ou sei explicar) a pendência do Anexo H — ficha de anamnese.
- Tenho a versão de 30 segundos pronta, caso o tempo seja cortado.

Na hora de falar

- Comece devagar. Os primeiros 30 segundos definem o ritmo de toda a apresentação.
- Pausas são suas aliadas — silêncio curto passa segurança; "é..." e "tipo assim" passam o contrário.
- Se travar num dado, não invente: diga "esse número está no artigo, posso confirmar depois".
- Se a banca interromper, escute a pergunta inteira antes de responder. Não interrompa de volta.
- Se não souber a resposta, diga com naturalidade: "não investiguei esse ponto neste estudo, mas é uma limitação que reconheço e uma boa sugestão para continuidade". Isso conta a favor.
- Mãos visíveis, pés firmes, ombros para trás. Evite ficar atrás do computador o tempo todo.

Uma última coisa: este trabalho tem uma força que poucos trabalhos de graduação têm — ele conta o que não funcionou e por quê, e ele recusa uma afirmação fácil (H. pylori causa queda) em favor de uma afirmação correta (fator associado, por má absorção). Apresente isso com orgulho, porque é exatamente isso que uma banca reconhece como método.